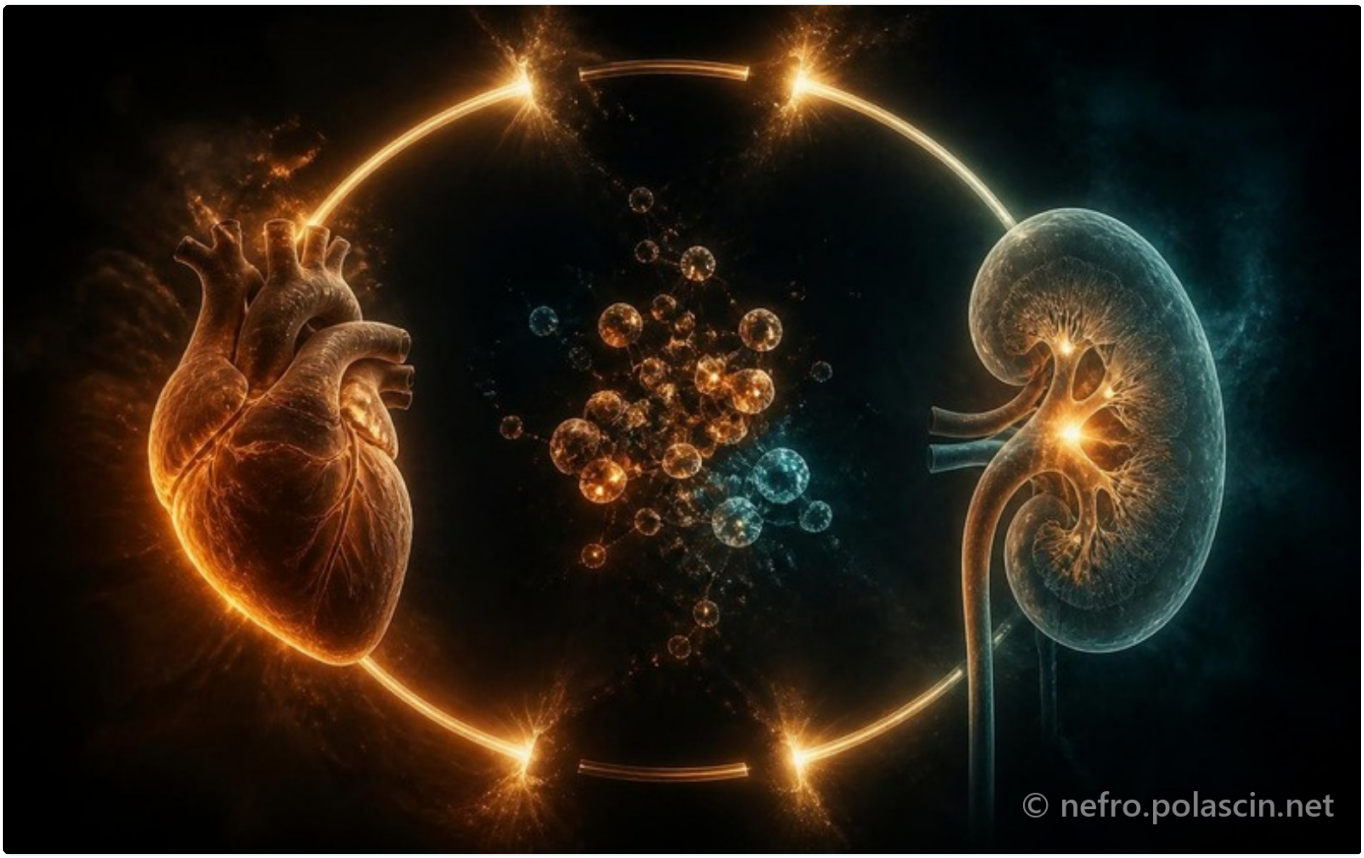
5 kritických chýb v manažmente CKM syndrómu a praktické kroky pre nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.06.2026



Ilustračná scéna. Nie je to jedna veľká chyba – starostlivosť sa stráca v medzerách medzi jednotlivými krokmi.

Prečo sa o CKM hovorí častejšie

Kardiovaskulárno-renálno-metabolický (CKM) syndróm je rámec, ktorý má prepojiť tri často „oddelené“ oblasti starostlivosti: kardiovaskulárne riziko, metabolické faktory a obličkové poškodenie. Článok na Medscape zdôrazňuje, že aj keď sa CKM rýchlo presadzuje a existujú naň prvé odporúčania, bežná prax naráža na staré zvyky a fragmentované myslenie.

Článok opisuje päť typických chýb, pre ktoré sa u pacientov s rizikom CKM oneskoruje diagnostika aj intervencia.

Chyba č. 1: Vynechanie testu uACR

Pomer albumínu ku kreatinínu v moči (uACR) je základný prediktor rizika a skríning albuminúrie je podľa nových odporúčaní indikovaný u pacientov s hypertriglyceridémiou, hypertenziou, metabolickým syndrómom alebo s diabetom 2. typu.

Článok upozorňuje, že test uACR sa v praxi robí zriedka: analýzy ukazujú, že veľká časť pacientov z rizikových skupín ho nedostala. Pre nefrológa je to podstatné, pretože rastúce hodnoty uACR sú kontinuálne spojené s rizikom progresie chronickej choroby obličiek aj s kardiovaskulárnou mortalitou a riziko sa môže objavovať už pri relatívne nízkych hodnotách.

Čo robiť v ambulancii a na oddelení: Nastaviť pracovné postupy tak, aby systém automaticky ponúkal uACR v rizikových situáciách CKM. Ak elektronická zdravotná dokumentácia nemá „laboratórny panel CKM“ ani štandardizovaný postup, oplatí sa požiadať o jeho doplnenie. Automatizácia znižuje pravdepodobnosť, že sa na test v časovom tlaku zabudne.

Chyba č. 2: Ignorovanie štádia 0

Článok pracuje so stupňovaním CKM od štádia 0 po štádium 4. Štádium 0 zahŕňa dospelých bez identifikovaných rizikových faktorov CKM.

Podstatné je, že „bez rizikových faktorov“ neznamená „bez budúceho rizika“. Čím skôr sa začnú preventívne opatrenia a edukácia, tým väčší je priestor na intervenciu skôr, než pacient prejde do vyšších štádií, kde sa kumuluje kardiovaskulárne aj renálne riziko.

Čo robiť: Pri mladších pacientoch (najmä ak sú riziká ešte nenápadné) zaradiť preventívne prvky podľa AHA „Life’s Essential 8“ a komunikáciu o CKM ako súčasť edukácie. Cieľom je zachytiť nefrologicky relevantné riziká včas a dať pacientovi jasný plán prevencie.

Chyba č. 3: Návrat k izolovanému (silo) prístupu

Článok na Medscape stavia proti sebe „starý svet“ prísne oddelených diagnóz a „nový svet“, v ktorom CKM slúži ako jednotná mentálna mapa.

Rámec CKM má uľahčiť predpisovanie liečby s viacerými cieľmi (multitarget), ktorá súčasne rieši kardiovaskulárne, metabolické aj renálne riziko (napríklad agonisty GLP-1 receptorov alebo inhibítory SGLT2). Nejde len o „nový názov“, ale o zmenu toho, ako ochotne lekári kombinujú intervencie.

Čo robiť: Vytvoriť si z odporúčaní vlastný zoznam liečby, ktorá prichádza do úvahy ako prvá. Článok odporúča začať pri vhodných pacientoch úvahou o agonistoch GLP-1 receptorov a/alebo inhibítoroch SGLT2 a zvažovať aj ďalšie liečebné postupy cielené na riziko.

Chyba č. 4: Predpoklad, že pacient si GLP-1 nemôže dovoliť

Častá bariéra nie je klinická, ale logistická a systémová. Článok priamo uvádza, že časť lekárov vníma lieky GLP-1 ako „nedostupné“, a nie ako realistickú voľbu pre konkrétneho pacienta.

Čo robiť: Držať GLP-1 v zozname možností a aktívne hľadať dostupné zľavové programy a cesty, ktoré umožnia liečbu začať. Pacient by nemal dostať len odmietavú odpoveď – treba podniknúť konkrétne kroky k získaniu dostupnej liečby.

Chyba č. 5: Nechať sa zastaviť zamietnutím poistného krytia

Indikácie aj podmienky úhrad sa môžu meniť. Článok upozorňuje, že zamietnutie žiadosti nemusí byť konečné. Niekedy môže k schváleniu viesť zmena prístupu, iné (viackritériové, „multi-kondičné“) zdôvodnenie alebo odlišné posúdenie ochorenia.

Čo robiť: Sledovať, pri ktorých kombináciách diagnóz a pacientskych profiloch poisťovňa (plán) kryje liečbu, a pri zamietnutí sa nebáť znova overiť podmienky. Pýtať sa poisťovne či poskytovateľa krytia, či je možné liek pre konkrétneho pacienta získať, a nevzdávať sa po prvom zamietnutí.

Zhrnutie pre nefrologickú prax

Ak sa má CKM syndróm premeniť z konceptu na rutinu, rozhodujúce je prepojiť pracovné postupy (najmä skríning uACR), načasovanie intervencií (vrátane štádia 0) a mentálny model starostlivosti (od izolovaného prístupu „diagnóza za diagnózou“ ku kombinovanej, rizikovo riadenej terapii). V systéme, kde môžu byť prekážky v dostupnosti liečby, je dôležitá aj aktívna práca s úhradovými podmienkami.

Zdroj: *Lisa O’Mary, 5 Critical Mistakes Doctors Make in Managing CKM, Medscape (2026).* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=5-kritickych-chyb-manazment-ckm-syndromu-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.